20 Catorze leituras para quem atende o adolescente que treina

Uma seleção comentada das fontes que sustentam a aula e o kit, com o dado que vale guardar de cada uma. Os links levam ao identificador digital do artigo (DOI, Digital Object Identifier).

O ponto de partida para nutrição do atleta adolescente

Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6

Revisão curta e prática: energia, proteína, carboidrato, ferro, cálcio, vitamina D, líquidos e suplementos, sempre com o crescimento em mente.

Para lembrar: Cerca de 1,5 g/kg/dia de proteína, ou 0,3 g/kg em cada uma de 5 refeições.

O consenso de 2024 sobre atletas jovens

Bergeron MF, Côté J, Cumming SP, Purcell R, Armstrong N, Basilico L, et al. IOC consensus statement on elite youth athletes competing at the Olympic Games: essentials to a healthy, safe and sustainable paradigm. Br J Sports Med. 2024;58(17):946-65. doi:10.1136/bjsports-2024-108186

Documento do Comitê Olímpico Internacional sobre desenvolvimento, saúde mental, carga de treino, nutrição e proteção de atletas jovens de elite.

Para lembrar: Suplementos permitidos, mas potencialmente nocivos, costumam ser estimulados sem análise válida de risco e benefício.

De onde vem a expressão “comida primeiro”

Close GL, Kasper AM, Walsh NP, Maughan RJ. "Food first but not always food only": recommendations for using dietary supplements in sport. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2022;32(5):371-86. doi:10.1123/ijsnem.2021-0335

Propõe uma definição para o princípio e discute quando o suplemento tem lugar.

Para lembrar: Comida primeiro, mas nem sempre só comida.

Quanto exercício recomendar

Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-62. doi:10.1136/bjsports-2020-102955

Diretrizes da Organização Mundial da Saúde para atividade física e comportamento sedentário, com recomendações por faixa etária.

Para lembrar: De 5 a 17 anos, média de 60 minutos por dia de atividade moderada a vigorosa, com fortalecimento muscular e ósseo em pelo menos 3 dias por semana.

O mapa dos suplementos no esporte de alto rendimento

Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027

Consenso do Comitê Olímpico Internacional com doses, efeitos e riscos de cada suplemento, incluindo contaminação e doping.

Para lembrar: Cerca de 15% de mais de 600 produtos tinham pró-hormônios não declarados, e o problema persiste.

Futebol de base, com seção própria para juniores

Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, Bilsborough J, Jeukendrup A, Morton JP, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. Br J Sports Med. 2021;55(8):416. doi:10.1136/bjsports-2019-101961

Declaração de especialistas da União das Federações Europeias de Futebol sobre nutrição no futebol de elite.

Para lembrar: Até 1,6 g/kg/dia de proteína para juniores, alcançável com a dieta, sem suplementos.

A posição da Academia Americana de Pediatria

LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300

Relatório clínico sobre substâncias para melhorar o desempenho em crianças e adolescentes, com sinais de alerta e orientações aos pais.

Para lembrar: O uso costuma ser clinicamente oculto, sem alterações confiáveis no exame físico.

Creatina em crianças e adolescentes: a revisão de referência

Jagim AR, Kerksick CM. Creatine supplementation in children and adolescents. Nutrients. 2021;13(2):664. doi:10.3390/nu13020664

Revisão dedicada à creatina em crianças e adolescentes; os autores são favoráveis ao uso, o que torna as ressalvas ainda mais relevantes.

Para lembrar: Nove estudos controlados de desempenho, todos com atletas (5 de natação e 4 de futebol, estes de 7 a 49 dias); os autores pedem ensaios desenhados para avaliar segurança.

Proteína em pó e uso posterior de outras substâncias

Nagata JM, Hazzard VM, Ganson KT, Austin SB, Neumark-Sztainer D, Eisenberg ME. Muscle-building behaviors from adolescence to emerging adulthood: a prospective cohort study. Prev Med Rep. 2022;27:101778. doi:10.1016/j.pmedr.2022.101778

Coorte que acompanhou 1.535 jovens da adolescência ao início da vida adulta.

Para lembrar: Risco relativo ajustado de 2,09 (intervalo de confiança de 95%, 1,29 a 3,39) para início posterior de esteroides ou outras substâncias em rapazes que usavam proteína em pó; associação, não causalidade.

O problema oposto: falta de energia

Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994

Consenso do Comitê Olímpico Internacional sobre deficiência energética relativa no esporte, com definição, modelos e a ferramenta de avaliação clínica CAT2 (Clinical Assessment Tool, versão 2).

Para lembrar: Avaliação de composição corporal em menores de 18 anos só com finalidade médica.

A posição brasileira sobre energéticos

Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. Consumo de bebidas energéticas por crianças e adolescentes. Documento Científico nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 2022 [citado 2026 out 12]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23377c-DC-Consumo_BebEnergeticas_crc_e_adl.pdf

Documento científico do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o consumo de bebidas energéticas.

Para lembrar: Energéticos não são apropriados para crianças e adolescentes; no Brasil, essas bebidas podem ter até 35 mg de cafeína por 100 mL.

O tamanho do fenômeno

Eisenberg ME, Wall M, Neumark-Sztainer D. Muscle-enhancing behaviors among adolescent girls and boys. Pediatrics. 2012;130(6):1019-26. doi:10.1542/peds.2012-0095

Estudo com 2.793 adolescentes de 20 escolas americanas, que termina recomendando ao pediatra perguntar sobre comportamentos para ganhar músculo.

Para lembrar: 34,7% dos meninos usavam proteína em pó ou shake.

Dismorfia muscular, do rastreio ao tratamento

Nagata JM, Hur JO, Murakami K, Ganson KT, He J, Murray SB, et al. Muscle dysmorphia in adolescents and young adults. Lancet Child Adolesc Health. 2026;10(2):122-34. doi:10.1016/S2352-4642(25)00283-4

Revisão recente sobre epidemiologia, fatores de risco, avaliação e tratamento em adolescentes e adultos jovens.

Para lembrar: Escore de 40 ou mais no Muscle Dysmorphic Disorder Inventory (MDDI) indica sintomas clinicamente significativos; a terapia cognitivo-comportamental é a principal abordagem.

A revisão brasileira, no Jornal de Pediatria

Barretto JR, Gouveia MADC, Alves C. Use of dietary supplements by children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2024;100 Suppl 1:S31-9. doi:10.1016/j.jped.2023.09.008

Suplementos em crianças e adolescentes: prevalência, indicações e riscos, para a realidade do consultório brasileiro.

Para lembrar: Proteína deve vir dos alimentos; a exceção são atletas adolescentes ou vegetarianos que não alcançam a meta com a dieta habitual.

LISTA COMPLETA

Todas as referências do kit, em ordem alfabética

REFERÊNCIAS COM MAIS DE DEZ ANOS

Entram por serem únicas ou de referência no tema: valores de referência de ingestão (Institute of Medicine, 2005); posição da Academia Americana de Pediatria sobre energéticos, ainda não substituída (2011); estudo populacional sobre comportamentos para ganhar músculo (Eisenberg, 2012); ensaio de prevenção conduzido dentro das equipes (Elliot, 2004); estudo internacional de contaminação de suplementos, citado no consenso do Comitê Olímpico Internacional de 2018 (Geyer, 2004); único ensaio que originou a hipótese sobre queda de cabelo (van der Merwe, 2009); revisão sobre cãibras e desidratação (Dalbo, 2008); revisão Cochrane sobre creatina em doenças musculares (Kley, 2013); estudo de validação do Low Energy Availability in Females Questionnaire (Melin, 2014); revisão sobre efeitos endócrinos dos esteroides anabolizantes (Nieschlag, 2015).

1. Almeida CC, Alvares TS, Costa MP, Conte-Junior CA. Protein and amino acid profiles of different whey protein supplements. J Diet Suppl. 2016;13(3):313-23. doi:10.3109/19390211.2015.1036187
2. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; Council on Sports Medicine and Fitness. Sports drinks and energy drinks for children and adolescents: are they appropriate? Pediatrics. 2011;127(6):1182-9. doi:10.1542/peds.2011-0965
3. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, et al. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? J Int Soc Sports Nutr. 2021;18(1):13. doi:10.1186/s12970-021-00412-w
4. Barretto JR, Gouveia MADC, Alves C. Use of dietary supplements by children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2024;100 Suppl 1:S31-9. doi:10.1016/j.jped.2023.09.008
5. Bergeron MF, Côté J, Cumming SP, Purcell R, Armstrong N, Basilico L, et al. IOC consensus statement on elite youth athletes competing at the Olympic Games: essentials to a healthy, safe and sustainable paradigm. Br J Sports Med. 2024;58(17):946-65. doi:10.1136/bjsports-2024-108186
6. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa alerta e orienta sobre o prazo de adequação às regras de regularização de alimentos [Internet]. Brasília: Anvisa; 2026 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-alerta-e-orienta-sobre-o-prazo-de-adequacao-as-regras-de-regularizacao-de-alimentos
7. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Creatinas: Anvisa divulga resultados de análise em suplementos [Internet]. Brasília: Anvisa; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/creatinas-anvisa-divulga-resultados-de-analise-em-suplementos
8. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
9. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
10. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Texto compilado disponível em: https://anvisalegis.datalegis.net
11. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 719, de 1º de julho de 2022. Dispõe sobre os requisitos sanitários das misturas para o preparo de alimentos e dos alimentos prontos para o consumo. Diário Oficial da União. 2022 jul 6; Seção 1.
12. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 843, de 22 de fevereiro de 2024. Dispõe sobre a regularização de alimentos e embalagens sob competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Texto compilado disponível em: https://anvisalegis.datalegis.net
13. Brasil. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O risco no consumo de produtos manipulados [Internet]. Brasília: ABCD; [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/gestao-de-resultados/analise-de-material-suspeito/o-risco-no-consumo-de-produtos-manipulados.pdf
14. Brasil. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Perguntas frequentes [Internet]. Brasília: ABCD; [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/abcd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes
15. Brasil. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Substâncias e métodos proibidos: Lista Proibida 2026 [Internet]. Brasília: ABCD; 2026 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.gov.br/abcd/pt-br/composicao/atletas/substancias-e-metodos-proibidos
16. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med. 2020;54(24):1451-62. doi:10.1136/bjsports-2020-102955
17. Close GL, Kasper AM, Walsh NP, Maughan RJ. "Food first but not always food only": recommendations for using dietary supplements in sport. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2022;32(5):371-86. doi:10.1123/ijsnem.2021-0335
18. Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, Bilsborough J, Jeukendrup A, Morton JP, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. Br J Sports Med. 2021;55(8):416. doi:10.1136/bjsports-2019-101961
19. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Brasília: CFM; 2019. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf
20. Dalbo VJ, Roberts MD, Stout JR, Kerksick CM. Putting to rest the myth of creatine supplementation leading to muscle cramps and dehydration. Br J Sports Med. 2008;42(7):567-73. doi:10.1136/bjsm.2007.042473
21. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
22. Eisenberg ME, Wall M, Neumark-Sztainer D. Muscle-enhancing behaviors among adolescent girls and boys. Pediatrics. 2012;130(6):1019-26. doi:10.1542/peds.2012-0095
23. Elliot DL, Goldberg L, Moe EL, Defrancesco CA, Durham MB, Hix-Small H. Preventing substance use and disordered eating: initial outcomes of the ATHENA (athletes targeting healthy exercise and nutrition alternatives) program. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(11):1043-9. doi:10.1001/archpedi.158.11.1043
24. Geyer H, Parr MK, Mareck U, Reinhart U, Schrader Y, Schänzer W. Analysis of non-hormonal nutritional supplements for anabolic-androgenic steroids: results of an international study. Int J Sports Med. 2004;25(2):124-9. doi:10.1055/s-2004-819955
25. Hargreaves D, Mates E, Menon P, Alderman H, Devakumar D, Fawzi W, et al. Strategies and interventions for healthy adolescent growth, nutrition, and development. Lancet. 2022;399(10320):198-210. doi:10.1016/S0140-6736(21)01593-2

26. Health Canada. Caffeine in foods [Internet]. Ottawa: Government of Canada; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/caffeine-foods.html
27. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academies Press; 2005. doi:10.17226/10490
28. Jagim AR, Kerksick CM. Creatine supplementation in children and adolescents. Nutrients. 2021;13(2):664. doi:10.3390/nu13020664
29. Kley RA, Tarnopolsky MA, Vorgerd M. Creatine for treating muscle disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD004760. doi:10.1002/14651858.CD004760.pub4
30. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, Wildman R, Collins R, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. doi:10.1186/s12970-017-0173-z
31. Kölner Liste [Internet]. [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.koelnerliste.com/
32. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
33. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, Trousselard M, Lesage FX, Dutheil F. Creatine supplementation and upper limb strength performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2017;47(1):163-73. doi:10.1007/s40279-016-0571-4
34. LGC Group. Informed Sport [Internet]. [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://sport.wetestyoutrust.com/
35. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027
36. Melin A, Tornberg AB, Skouby S, Faber J, Ritz C, Sjödin A, et al. The LEAF questionnaire: a screening tool for the identification of female athletes at risk for the female athlete triad. Br J Sports Med. 2014;48(7):540-5. doi:10.1136/bjsports-2013-093240
37. van der Merwe J, Brooks NE, Myburgh KH. Three weeks of creatine monohydrate supplementation affects dihydrotestosterone to testosterone ratio in college-aged rugby players. Clin J Sport Med. 2009;19(5):399-404. doi:10.1097/JSM.0b013e3181b8b52f
38. Morton RW, Murphy KT, McKellar SR, Schoenfeld BJ, Henselmans M, Helms E, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018;52(6):376-84. doi:10.1136/bjsports-2017-097608
39. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994
40. Nagata JM, Hazzard VM, Ganson KT, Austin SB, Neumark-Sztainer D, Eisenberg ME. Muscle-building behaviors from adolescence to emerging adulthood: a prospective cohort study. Prev Med Rep. 2022;27:101778. doi:10.1016/j.pmedr.2022.101778
41. Nagata JM, Hur JO, Murakami K, Ganson KT, He J, Murray SB, et al. Muscle dysmorphia in adolescents and young adults. Lancet Child Adolesc Health. 2026;10(2):122-34. doi:10.1016/S2352-4642(25)00283-4
42. Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in endocrinology: medical consequences of doping with anabolic androgenic steroids: effects on reproductive functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2):R47-58. doi:10.1530/EJE-15-0080
43. NSF International. NSF Certified for Sport [Internet]. [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.nsfsport.com/
44. Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785-6. doi:10.5664/jcsm.5866
45. Ream MA, Lam WKK, Grosse SD, Ojodu J, Jones E, Prosser LA, et al. Evidence and recommendation for guanidinoacetate methyltransferase deficiency newborn screening. Pediatrics. 2023;152(2):e2023062100. doi:10.1542/peds.2023-062100
46. Simpson AJ, Horne S, Sharp P, Sharps R, Kippelen P. Effect of creatine supplementation on the airways of youth elite soccer players. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(8):1582-90. doi:10.1249/MSS.0000000000001979
47. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. Consumo de bebidas energéticas por crianças e adolescentes. Documento Científico nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 2022 [citado 2026 out 12]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23377c-DC-Consumo_BebEnergeticas_crc_e_adl.pdf
48. Society for Adolescent Health and Medicine. Confidential healthcare for adolescent minors and young adults: a position paper of the Society for Adolescent Health and Medicine. J Adolesc Health. 2025;77(4):791-6. doi:10.1016/j.jadohealth.2025.06.006
49. Souza AM, Barufaldi LA, Abreu GA, Giannini DT, de Oliveira CL, dos Santos MM, et al. ERICA: intake of macro and micronutrients of Brazilian adolescents. Rev Saude Publica. 2016;50 Suppl 1:5s. doi:10.1590/S01518-8787.2016050006698
50. Steffl M, Kinkorova I, Kokstejn J, Petr M. Macronutrient intake in soccer players: a meta-analysis. Nutrients. 2019;11(6):1305. doi:10.3390/nu11061305
51. Stellingwerff T, Mountjoy M, McCluskey WT, Ackerman KE, Verhagen E, Heikura IA. Review of the scientific rationale, development and validation of the International Olympic Committee Relative Energy Deficiency in Sport Clinical Assessment Tool: V.2 (IOC REDs CAT2)-by a subgroup of the IOC consensus on REDs. Br J Sports Med. 2023;57(17):1109-18. doi:10.1136/bjsports-2023-106914
52. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) [Internet]. Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.3. São Paulo; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: http://www.fcf.usp.br/tbca
53. Torstveit MK, Ackerman KE, Constantini N, Holtzman B, Koehler K, Mountjoy ML, et al. Primary, secondary and tertiary prevention of Relative Energy Deficiency in Sport (REDs): a narrative review by a subgroup of the IOC consensus on REDs. Br J Sports Med. 2023;57(17):1119-26. doi:10.1136/bjsports-2023-106932
54. Tsiaras A, Loufopoulos G, Theodoridis X, Liakopoulos V, Poulia KA, Chourdakis M. The effect of creatine supplementation on kidney function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Ren Nutr. 2026 Apr 24. doi:10.1053/j.jrn.2026.04.010. [Epub ahead of print]
55. Tucker J, Fischer T, Upjohn L, Mazzera D, Kumar M. Unapproved pharmaceutical ingredients included in dietary supplements associated with US Food and Drug Administration warnings. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183337. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3337
56. Verduci E, Köglmeier J, Haiden N, Kivelä L, de Koning B, Hill S, et al. Vegan diet and nutritional status in infants, children and adolescents: a position paper based on a systematic search by the ESPGHAN Nutrition Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2025;81(5):1318-45. doi:10.1002/jpn3.70182